

流感疫苗政策綜論

疾病管制署新興傳染病整備組



大綱

- 我國流感疫苗接種計畫歷年執行情形
- 115年度流感疫苗接種計畫
- 流感疫苗接種作業執行重點提醒
 - 流感疫苗管理注意事項
 - 接種作業注意事項及重點對象接種情形

我國流感疫苗接種計畫 歷年執行情形

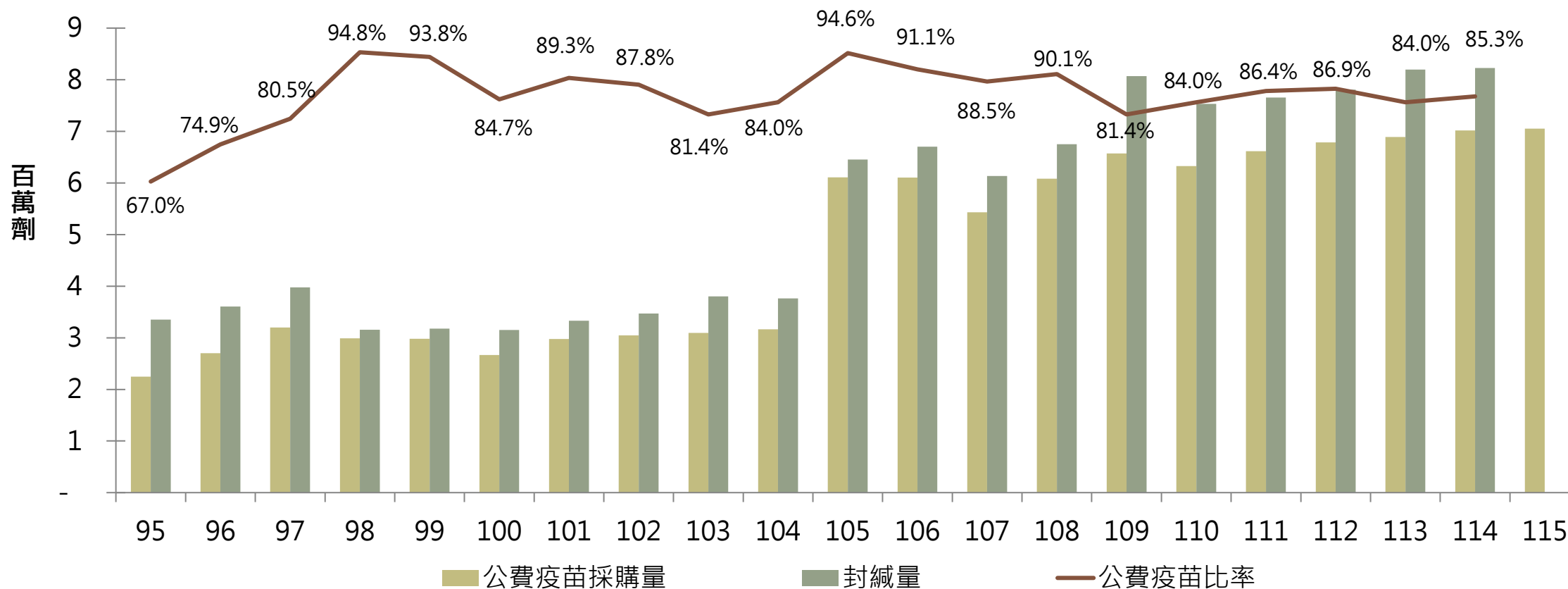
計畫緣起

為避免因罹患流感導致嚴重併發症或死亡，民國87年試辦「**65歲以上高危險群老人流感疫苗接種先驅計畫**」，並依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議逐年擴大實施對象，包括感染流感後容易併發重症之高危險族群，如長者、孕婦與幼兒等，以及容易群聚感染之高傳播族群，如國小/國中/高中職/五專1-3年級學生與醫事及衛生防疫相關人員等



歷年流感疫苗採購量

- 近幾年維持**近700萬劑**之公費流感疫苗採購規模



重點對象各國接種情形比較-長者



國家	臺灣*	美國	韓國	加拿大	英國	荷蘭	澳洲	日本
年度	2025/26	2023/24	2023/24	2024/25	2024/25	2022/23	2024	2024/25
65歲以上老人	51.5%	69.7%	82.5%	63.0%	74.9%	68.4%	61.7%	54.6%
*：統計期間為2025/10/1-2026/06/30								

- 65歲以上長者由於身體機能衰退、抵抗力下降，罹患流感後易引起嚴重併發症，如急性支氣管炎、肺炎及住院與死亡的機率遠高於其他健康成人，因此將65歲以上長者納入接種對象

重點對象各國接種情形比較-幼兒



國家	臺灣*	美國	英國	澳洲
年度	2025/26	2023/24	2024/25	2024
學齡前幼兒 (至少接種1劑)	69.7%	64.2% (6月-4歲)	42.6% (2-3歲)	27.6% (6月-5歲)

*：統計期間為2025/10/1-2026/06/30

- 學齡前幼兒為流感重症高危險群，感染後有10%至50%會併發中耳炎，併發重症以肺炎為主，且腦膜炎、橫貫性脊髓炎、多發性神經炎GBS等神經系統併發症機率比成年人高，萬一發生金黃色葡萄球菌、肺炎鏈球菌等續發性細菌感染，更易造成重症或死亡

重點對象各國接種情形比較-醫事人員



國家	臺灣*	美國	英國
年度	2025/26	2023/24	2023/24
執登醫事人員	73.1%	75.4%	42.8%

*：統計期間為2025/10/1-2026/06/30

- 醫事人員接種流感疫苗，可避免在執行照護工作時受到病人的傳染，或因自身感染流感而將病毒傳染給病人
- 對於醫療機構來說，機構內醫療照護人員的流感疫苗接種，可避免工作場所因流感爆發而影響其健康照護工作的執行，節省醫療成本支出
- 另面對民眾之疫苗猶豫，醫護人員扮演風險溝通要角及可靠的訊息來源，自身的知識及態度影響自身接種率、向病人說明的意圖及病人接種率

重點對象各國接種情形比較-學生



國家	臺灣*	美國	韓國	澳洲
年度	2025/26	2023/24	2023/24	2024
國小	77.4%	57.0% (5-12歲)	68.8% (7-9歲) 61.6% (10-12歲)	15.6% (5-9歲)
國中 (13-15歲)	76.1%	46.9% (13-17歲)	49.2% (13歲)	13.3% (10-19歲)
高中 (16-18歲)	58.4%		-	

*：統計期間為2025/10/1-2026/06/30

- 流感病毒對於學齡兒童具有高侵襲性，且其為流感病毒之重要傳播者
- 學生接種疫苗，除可保護自己，也間接保護社區中的老人及幼兒等高危險族群

115年度流感疫苗接種計畫

實施經費

● 疫苗經費

1. 政府提供的流感疫苗是免費的
2. 疫苗經費由本署及地方政府依縣市財力分級及分攤比例原則，共同負擔

● 醫療費用

1. 掛號費

- 民眾需依門診規定，自付掛號費及其他接種相關醫療費用
- 部分對象之掛號費由衛生局（所）與合約醫院簽約時，協定免付掛號費

2. 接種處置費

- 由疾病管制署依據合約院所上傳NIIS之接種資料核算，並將核付清單定期送健保署撥付接種處置費，合約院所不得再向民眾收取診察費。
- 一般民眾每劑次補助150元，6歲以下（接種日未滿7歲）幼兒每劑次補助200元

115年度WHO建議三價疫苗病毒株

- 雞胚胎蛋培養疫苗

- A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09-like virus
- A/Darwin/1454/2025 (H3N2)-like virus
- B/Tokyo/EIS13-175/2025 (B/Victoria lineage)-like virus

- 細胞培養或重組疫苗

- A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09-like virus
- A/Darwin/1415/2025 (H3N2)-like virus
- B/Pennsylvania/14/2025 (B/Victoria lineage)-like virus

註：黃底表該病毒株與114-115疫苗株不同

115年度流感疫苗採購情形-標準型

許可證持有廠商	疫苗品名	適用年齡 ^{註1}	劑型	供貨數量 ^{註2}	疫苗製程
國光生物科技 股份有限公司	AdimFlu-S 安定伏裂解型流感疫苗	3歲以上	0.5mL	319萬劑8,450劑	雞胚胎蛋培養 (egg-based)
荷商葛蘭素史克藥廠股 份有限公司台灣分公司	Fluarix Trivalent 伏流感疫苗	6個月以上	0.5mL	178萬5,460劑	雞胚胎蛋培養 (egg-based)
賽諾菲股份有限公司	Vaxigrip 菲流達三價流感疫苗	6個月以上	0.5mL	79萬540劑	雞胚胎蛋培養 (egg-based)
台灣東洋藥品工業 股份有限公司	Flucelvax 輔流威護流感疫苗	6個月以上	0.5mL	64萬6,900劑	細胞培養 (cell-based)
高端疫苗生物製劑 股份有限公司	Fluvacgen 福喜健三價流感疫苗	3歲以上	0.5mL	42萬8,010劑	雞胚胎蛋培養 (egg-based)

註1：以食藥署核准之仿單說明為準

註2：共計採購**684萬9,360劑**；包含115年度流感疫苗接種計畫實施對象所需疫苗量**644萬8,960劑**、中央及地方委託代購量**20萬400劑**，及可視實際需求再額外下訂之數量**20萬劑**

提醒

國光及高端公司疫苗**不可**用於
3歲以下幼兒！

115年度流感疫苗採購情形-加強型

許可證持有廠商	疫苗品名	適用年齡 ^{註1}	劑型	供貨數量 ^{註2}	疫苗製程
台灣東洋藥品工業股份有限公司	Fluad 輔流禦流感疫苗	50歲以上	0.5mL	11萬7,470劑	雞胚胎蛋培養 (egg-based)
賽諾菲股份有限公司	Efluelda High-Dose Trivalent Influenza Vaccine 菲優達高劑量三價流感疫苗	65歲以上	0.5mL	8萬3,320劑	雞胚胎蛋培養 (egg-based)

註1：以食藥署核准之仿單說明為準

註2：共計採購**20萬790劑**；包含115年度流感疫苗接種計畫實施對象所需疫苗量**17萬790劑**、可視實際需求再**額外下訂**之數量**3萬劑**

加強型流感疫苗介紹

- 研究顯示，相較標準型流感疫苗，加強型流感疫苗對65歲以上長者有較佳保護力
- 國內上市之加強型流感疫苗：

疫苗	作用原理	臨床試驗	許可證取得日期																																										
含佐劑-輔流禦流感疫苗(東洋)	添加佐劑，加強接種後的免疫反應	<table><tr><th>Study</th><th>Season(s)</th><th>aTIV/aQIV vs TIV</th><th>aTIV/aQIV, n</th><th>QIV/TIV, n</th><th>Outcome</th><th>Adjusted rVE, % (95% CI)</th></tr><tr><td>Van Buynder et al. 2013¹</td><td>2011/12</td><td>TIV</td><td>165</td><td>62</td><td>Lab-confirmed influenza: community</td><td>63 (-4, 86)</td></tr><tr><td>Pott et al. 2023⁹</td><td>2012/13-2014/15</td><td>TIV</td><td>526</td><td>3,364</td><td></td><td>14 (-4, 29)^a</td></tr><tr><td>Domnich et al. 2022¹⁵</td><td>2018/19, 2019/20</td><td>QIV</td><td>337</td><td>175</td><td>Lab-confirmed influenza: hospitalisation</td><td>59.2 (14.6, 80.5)</td></tr><tr><td>Ku et al. 2024¹⁸</td><td>2022/23</td><td>QIV</td><td>23,508</td><td>69,006</td><td></td><td>61.6 (18.1, 82)</td></tr><tr><td>Gravenstein et al. 2021²</td><td>2016/17</td><td>TIV</td><td>387</td><td>390</td><td>Lab-confirmed influenza outbreaks in a long-term care facility</td><td>22 (-2, 40)</td></tr></table>	Study	Season(s)	aTIV/aQIV vs TIV	aTIV/aQIV, n	QIV/TIV, n	Outcome	Adjusted rVE, % (95% CI)	Van Buynder et al. 2013 ¹	2011/12	TIV	165	62	Lab-confirmed influenza: community	63 (-4, 86)	Pott et al. 2023 ⁹	2012/13-2014/15	TIV	526	3,364		14 (-4, 29) ^a	Domnich et al. 2022 ¹⁵	2018/19, 2019/20	QIV	337	175	Lab-confirmed influenza: hospitalisation	59.2 (14.6, 80.5)	Ku et al. 2024 ¹⁸	2022/23	QIV	23,508	69,006		61.6 (18.1, 82)	Gravenstein et al. 2021 ²	2016/17	TIV	387	390	Lab-confirmed influenza outbreaks in a long-term care facility	22 (-2, 40)	114/1/10
Study	Season(s)	aTIV/aQIV vs TIV	aTIV/aQIV, n	QIV/TIV, n	Outcome	Adjusted rVE, % (95% CI)																																							
Van Buynder et al. 2013 ¹	2011/12	TIV	165	62	Lab-confirmed influenza: community	63 (-4, 86)																																							
Pott et al. 2023 ⁹	2012/13-2014/15	TIV	526	3,364		14 (-4, 29) ^a																																							
Domnich et al. 2022 ¹⁵	2018/19, 2019/20	QIV	337	175	Lab-confirmed influenza: hospitalisation	59.2 (14.6, 80.5)																																							
Ku et al. 2024 ¹⁸	2022/23	QIV	23,508	69,006		61.6 (18.1, 82)																																							
Gravenstein et al. 2021 ²	2016/17	TIV	387	390	Lab-confirmed influenza outbreaks in a long-term care facility	22 (-2, 40)																																							
高劑量-菲優達高劑量三價流感疫苗(賽諾菲)	每株病毒抗原含量為60µg，是標準型流感疫苗的4倍，可誘發更強的免疫反應	CLINICAL ENDPOINTS EFFICACY DATA¹ Randomized Controlled Trial (1:1) vs standard dose (SD-IIV) Superiority objective 32,000 subjects aged 65+ years across two seasons Lab-confirmed influenza infection +24.2% (95% CI: 9.7-36.5) relative efficacy against lab-confirmed influenza infection	114/8/6																																										

•含佐劑：1.Van Buynder P, et al. Vaccine 2013; 31(51):6122-8; 2.GravensteinS, et al. Clin Infect Dis 2021; ciae1916.; 15. Domnich, A, et al. Int J Infect Dis 2022.125(2022): 164-96.; 18. Ku et al. Clinical Infectious Diseases 2024 Aug
•高劑量：DiazGranados CA, et al. N Engl J Med. 2014; 371:635-45

115年度公費流感疫苗政策更新(1)

- 國內上市之加強型流感疫苗為含佐劑及高劑量兩種，研究顯示，相較標準型流感疫苗，加強型流感疫苗對65歲以上長者有較佳保護力，美英加澳等國皆已建議長者優先接種加強型疫苗，兩者在長者族群保護效果相近
- 經財團法人醫藥品查驗中心研究評估符合成本效益，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議將加強型流感疫苗列為優先推動疫苗政策
- 目前國內兩款疫苗均已取得許可證，115年度秋冬起，採購20萬劑加強型流感疫苗優先供長照及安養機構65歲以上長者接種，以強化高齡族群免疫屏障

115年度公費流感疫苗政策更新(2)

● 幼兒流感疫苗接種建議調整：

依國際研究結果及參酌國際接種建議，未滿3歲兒童於初次接種流感疫苗時，完整接種2劑兒童可顯著提升保護效益，爰調整季節性流感疫苗接種劑次建議(115年3月11日ACIP第1次會議決議)

流感疫苗過去接種史 ^{註1} / 年齡組 ^{註2}	未曾接種	僅曾接種 1劑者	曾接種 2劑者
6個月以上至未滿3歲	2劑 (間隔4週以上)		1劑
3歲以上至未滿9歲	2劑 ^{註3} (間隔4週以上)	1劑	
9歲以上	1劑		

註1：流感疫苗過去接種史採當流感季前累計接種劑數計算，不限於同一個流感季接種

註2：參依國際間接種建議，依幼兒於當年度流感季接種第1劑時之所屬年齡組及過去接種史，判定當年度流感季應接種劑數

註3：未滿9歲但已入學者，依據99年3月23日ACIP第1次會議決議，國小學童於學校集中接種流感疫苗，考量接種率、實務執行等因素，統一提供1劑公費疫苗，故國小一、二年級學童若有第2劑流感疫苗接種需求，可於學校接種第1劑至少隔4週後，至醫療院所自費接種第2劑

以115年10月1日開打為例，

- **範例一**：112年4月出生之幼兒，曾於112年11月(滿7個月)接種一劑流感疫苗，115年10月(滿3歲6個月)僅需接種一劑流感疫苗
- **範例二**：112年11月出生之幼兒，曾於114年12月(滿2歲1個月)流感季接種一劑流感疫苗，則115年流感季接種情境如下：
 1. 若於115年10月(滿2歲11個月)接種115年流感疫苗，因未滿3歲且過往累計僅接種一劑，故應於間隔四週後接種第二劑
 2. 若於115年12月(3歲1個月)接種115年流感疫苗，則無需接種第二劑
- **範例三**：109年2月出生之國小一年級學童，出生至今未曾接種過流感疫苗，115年11月於學校接種一劑公費流感疫苗後，可於四週後自行前往醫療院所自費接種第二劑

115年流感疫苗接種計畫實施對象

- 實施對象：115年度流感疫苗接種計畫各類實施對象，需具**中華民國國民身分**[如為外籍人士，需持有**居留證**(包含外交官員證、國際機構官員證及外國機構官員證)]，並符合各類對象所列條件

階段順序	實施對象
第一階段 (115/10/1起) ★重點對象 目標接種率	● 醫事及衛生防疫相關人員 ★目標75% ● 65歲以上長者 ★目標55% ● 55歲以上原住民 ● 安養、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及其所屬工作人員 ● 滿6個月以上至國小入學前幼兒 ★目標65% ● 孕婦 ● 具有潛在疾病者，包括(19-64歲)高風險慢性病人、BMI$\geq$30者、罕見疾病患者及重大傷病患者 ● 6個月內嬰兒之雙親或實際扶養者^{註1} ● 幼兒園及托育機構工作人員、居家托育人員(保母)^{註2} ● 國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生 ★目標75% ● 禽畜相關及動物防疫相關人員
第二階段 (115/11/2起)	50至64歲無高風險慢性病成人

註1：如祖父母、外祖父母、與被收養/寄養嬰兒有「先行共同生活」事實之實際扶養者等，並應持有嬰兒出生證明文件或完成新生嬰兒登記之戶口名簿或足堪認定有「先行共同生活」之證明文件，依個案事實從寬認定；註2：115年度起新增納入托嬰中心廚工及行政人員等非臨時性工作人員

115年接種處置費給付變革(1)

- 依本署急性傳染病組114年12月29日疾管防字第1140201156號函，自115年3月1日起(按接種日期)：
 1. 兒童常規疫苗、成人肺炎鏈球菌疫苗及流感疫苗接種處置費，調整由本署每月依NIIS核算核付(代付)，取消原有健保申報作業(代收代付)
 2. 調升公費疫苗接種處置費，將6歲以下幼兒(接種日未滿7歲)調升為200元/劑次、其餘對象調升為150元/劑次
- 倘合約院所自115年3月1日起仍併同其他醫療費用向健保申報處置費，則健保署將整包剔退不予核付，故請醫療院所務必向HIS廠商確認已關閉健保處置費申報路徑
- 不予核付接種處置費情形：NIIS系統疫苗批號結尾不為-CDC、異常接種劑次(如：不符合接種年齡/資格或接種間隔規範、重複接種等情形)、異常登錄劑次(如：非首次接種流感疫苗者以第2劑登錄、流感疫苗接種身分別不符等情形)於4個月(即接種月之次月起3個月)內未修正、未於4個月內上傳接種資料者、非合約院所接種
- 校園案件資料上傳NIIS時，不需註記「校園接種」

115年接種處置費給付變革(2)

- 區管、衛生局/所、合約院所均可透過NIIS)9.1.9處置費核算[合約院所版為HIQS)5.2處置費核算查詢]自行查詢接種資料上傳及檢核結果(可參考匯出清冊「核付狀態」及「未核付說明」欄位)

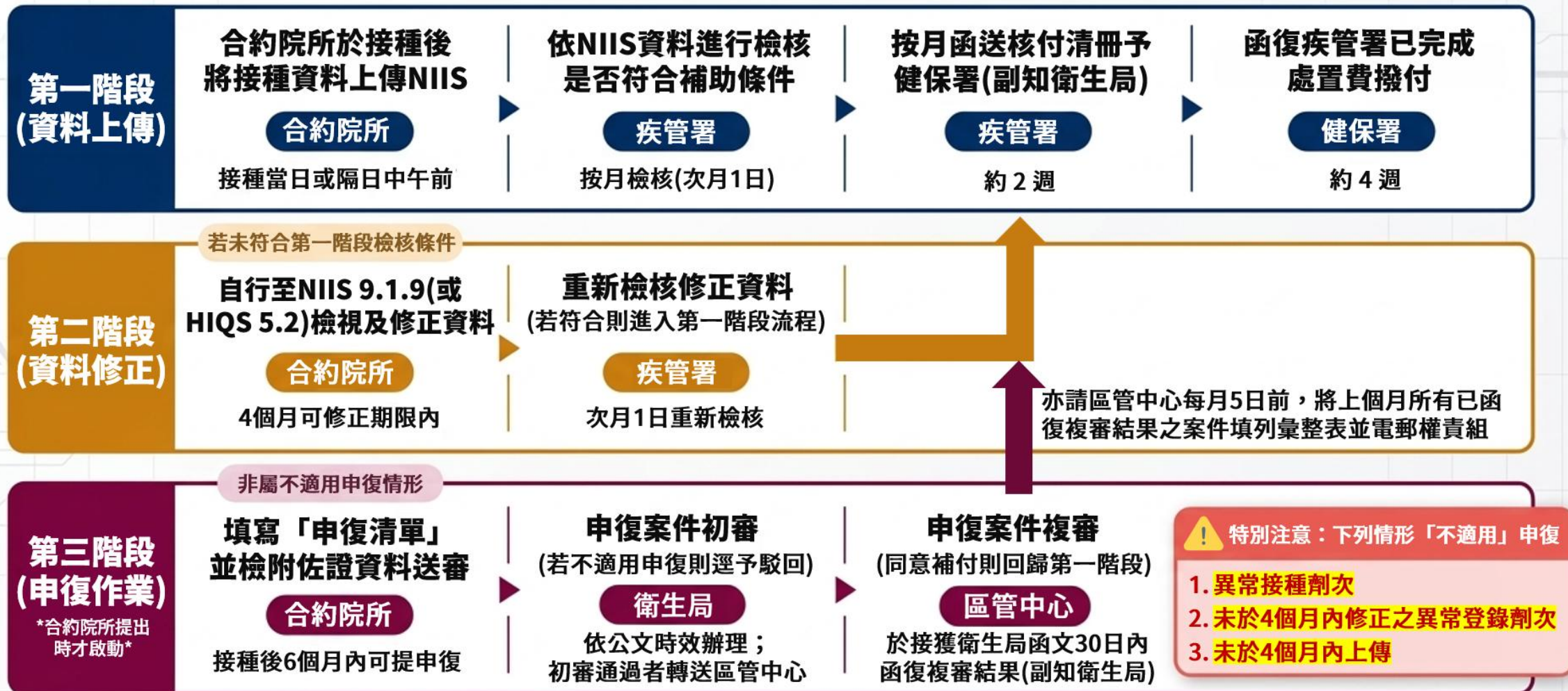
證號	出生日期	姓名	接種日期	建檔日期	異動日期	疫苗代碼	劑次	批號	單位層級	院所十碼	院所名稱	接種縣市	接種鄉鎮	接種身分	處置費註記	未核付說明	核付狀態	核付月份	給付金額
P22058	640717	張 壽	1150303	1150303	1150303	Flu		1 FKAA2509	合約院所	3.5E+09	萬安診所	臺中市	清水區	F03A			核付	1150401	150
N2231	660129	陳 彬	1150331	1150331	1150331	Flu		1 P10085132	衛生所	2.34E+09	彰化縣和	彰化縣	和美鎮	F03A		接種身分別不符	未核付		0
M1213	620710	譚 蔭	1150302	1150302	1150302	Flu		2 P10085132	合約院所	3.53E+09	北大小兒	新北市	三峽區	F03A		異常劑次/接種	未核付		0
9.92E-	410306	羅 進	1141202	1141202	1141202	Flu		1 P10084555	合約院所	1.54E+09	道安醫院	彰化縣	溪湖鎮	F04A		99未明	不核付	1150401	0
C2219	1090412	許 堯	1141230	1141230	1141230	Flu		1 AFLUA915	衛生所	2.31E+09	基隆市中	基隆市	中正區	F01	已領取醫護人力支援費	處置費註記	不核付	1150401	0
J20126	300122	林 芳	1141218	1150429	1150429	Flu		1 FKZA2501	合約院所	3.51E+09	恆生診所	基隆市	仁愛區	F03A			逾期上傳不核付		0

- 屬異常登錄劑次且核付狀態為「未核付」者，於4個月(即接種月之次月起3個月)期限內可透過下列方式修正
 - HIS API：請於HIS系統介面修正後，接種資料將透過HIS API自動傳送至NIIS系統進行更新，惟因各家HIS系統頁面設計不同，如有操作問題，建議逕洽所屬HIS廠商詢問
 - 媒體資料匯入(無法單筆修改/刪除)：請洽所屬衛生局開立應用系統維護單，敘明合約院所名稱/十碼章、檔案上傳時間、筆數予本署作為批次刪除依據，待本署刪除檔案後隔日，再重新整批上傳
 - 單筆登錄：衛生所可逐筆修正接種資料
- 合約院所對於不核付案件，得於接種後6個月(即接種月之次月起5個月)檢具相關文件，向所在地衛生局提出申復，經衛生局初審屬適用申復者，轉送本署各區管制中心辦理複審

註：**不適用申復且不予補付情形**：1.異常接種劑次、2.未於4個月內完成修正異常登錄劑次、3.未於4個月內上傳接種資料情形

接種處置費核付及申復作業流程總覽

- ◆ 接種日期自115年3月1日起之案件適用，併調升接種處置費：6歲以下(未滿7歲)200元/劑、7歲以上150元/劑
- ◆ 資料修正期限：接種4個月(即接種月之次月起 3個月)內



重點提醒!

流感疫苗接種作業執行

衛生局辦理115年度流感疫苗接種工作重要時程

工作事項	115年												116年	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
核撥115年補助經費														
合約院所簽訂作業														
校園接種行政契約/採購案														
院所聯繫會議暨執行前說明會														
流感疫苗開打記者會														
轄內疫苗調度及重點族群催注														
115年補助經費核銷														

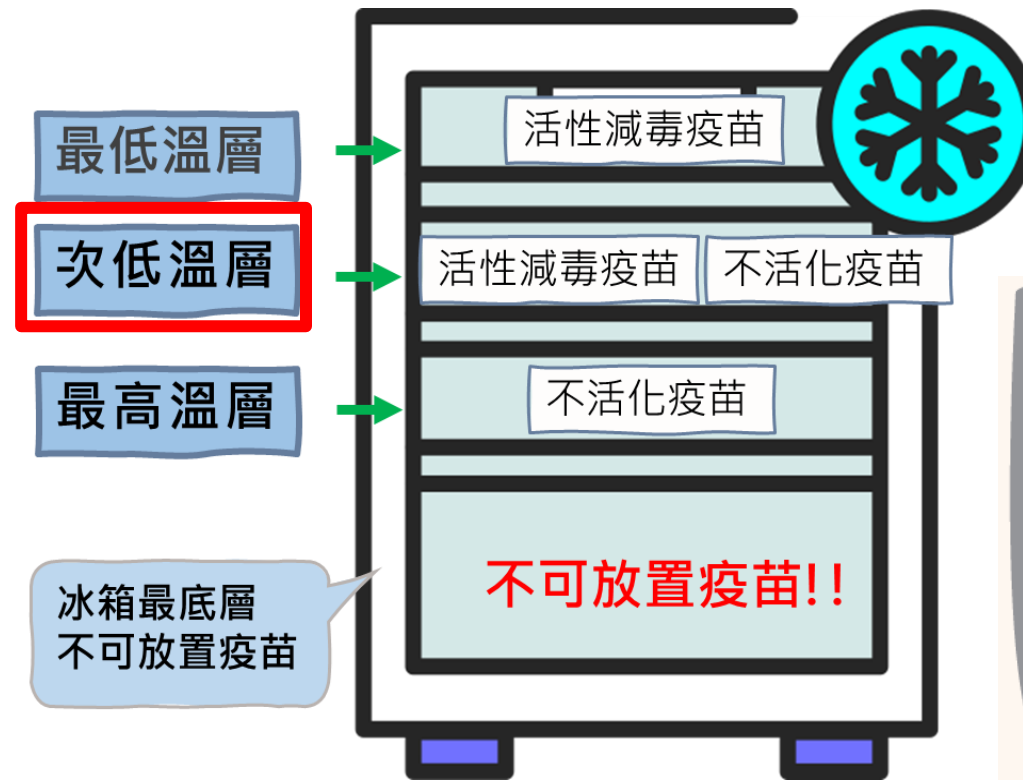
※經費核銷務必準時(12月21日前)！

流感疫苗管理注意事項

流感疫苗入庫管理原則(1/2)

• 流感疫苗冷儲條件

1. **【存放溫度維持2~8°C】** 流感疫苗屬不活化疫苗，應避免低於2°C(凍結將導致疫苗效力永久受損且無法恢復)；活性減毒疫苗(LAIV)則應避免高於8°C
2. **【放置次低溫層】** 流感疫苗應存放於冰箱的「次低溫層」，並建議將凍片2片及Data logger置放於不活化疫苗(次低溫層)之最低溫區域
3. **【日常設備監控與紀錄管理】** 每日監測及紀錄溫度、定期測試/保養各項系統設備(如：冷藏櫃/保全系統、不斷電系統、Data logger等)並留存紀錄
4. **【冷藏設備擺放正確】** 電源應使用專用插座且電壓負荷充足；電源插頭應使用適當膠布妥善固定於插座(加註標示提醒)以防脫落；離牆至少10公分以利散熱；兩個以上之冰箱應予編號並儘可能放置同一處



如使用家用雙層冰箱，可於冰箱最上層、最底層及門邊擺置寶特瓶裝水，使冰箱易於維持恆溫



流感疫苗入庫管理原則(2/2)

• 疫苗擺放及標示原則

1. 疫苗較大量滿載時可能影響溫度分布，須重新分區域監測，據以置放疫苗，且應注意疫苗**不能靠壁**，四周(上下左右前後)及各疫苗區域間**應留有充足間隙**，以利空氣迴流
2. **非透明玻璃門之冷藏櫃**，需製作**冰箱平面配置圖**；透明玻璃門之冷藏櫃不須製作平面配置圖，但建議仍需於各層標示最高溫、最低溫、次高溫、次低溫層
3. **先進先出**、依疫苗特性分層擺放，並以明顯字體清楚**標示疫苗名稱、劑型、廠牌、批號、效期**(如右圖)
4. **公自費疫苗明顯標示並分開擺放**

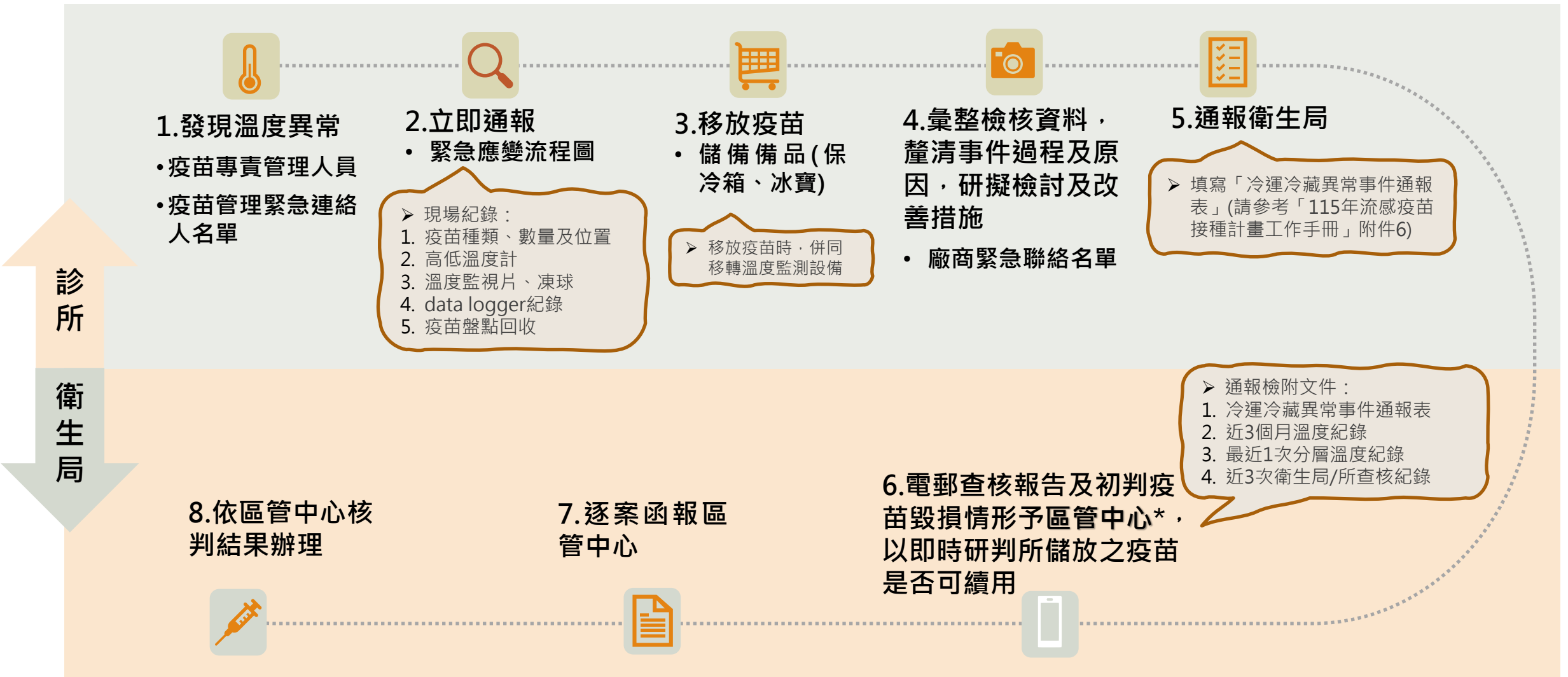


Flu	
疫苗名稱：流感疫苗(公費)	
劑型：單劑型 廠牌：Sanofi Pasteur	
有效日期：113 年 08 月 31 日	
批號：X3E851V-CDC	

常見冷運冷藏異常事件樣態

異常情形	高溫異常	低溫異常	其他
可能情境	冷藏設備電力中斷	疫苗或溫度紀錄裝置 放置於出風口	使用未經溫度監測之 冷藏設備儲存疫苗
	冰箱門未關好	疫苗冷運包裝不當， 冰寶直接接觸疫苗	未按時下載data logger 紀錄，衛生局所查核時始 發現溫度異常
	冷藏設備故障	冷藏設備故障	data logger沒電
	冰箱儲存過滿		每日溫度紀錄不確實

冷運冷藏異常事件之應變處理



疫苗問題產品通報及處理-疫苗不良品

① 發現疫苗不良品



疫苗**內容物異常**，如顏色不符仿單、搖晃後有異物(黑點、白點、漂浮物、結塊、分層等)，或其他與仿單描述不符的情況

② 合約院所



- 1.妥善保存疫苗，**勿拆針蓋避免汙染**
- 2.通知衛生局並附照片
- 3.依指示**冷藏**送回或等待廠商取回
- 4.填寫「疫苗不良品通報表」
- 5.必要時出席專家會議說明



切勿透過LINE或電郵等公用群組詢問及轉傳



④ 疾管署整備組

- 1.通知廠商/衛生局**冷藏**送疫苗至食藥署
- 2.清查同批疫苗是否有類似事件
- 3.必要時召開專家會議
- 4.依會議決議是否繼續使用



③ 衛生局(所)

- 1.收集資料並電郵疾管署
- 2.依通知由衛生局或廠商**冷藏**取回疫苗
- 3.填寫「疫苗不良品通報表」
- 4.配合清查同批號疫苗
- 5.NIIS系統登錄退貨通報
- 6.必要時出席專家會議說明

疫苗問題產品通報及處理-疫苗其他瑕疵

① 發現疫苗瑕疵品



包含瓶身破裂、無標籤、髒汙、蓋子瑕疵、針頭/推柄異常、疫苗量不足、短缺或缺稀釋液等情形

② 合約院所



1. 填寫「流感疫苗瑕疵通報表」
2. 電郵照片給衛生局
3. 送回疫苗實體(未送回需賠償)



④ 疾管署整備組

向廠商**退換疫苗**



③ 衛生局(所)

1. 至 NIIS 系統退貨登錄通報
2. 疫苗**實體**連同瑕疵通報表函送疾管署，原則**每月底**前送回，至隔年3月止

疫苗毀損處理作業

- **疫苗毀損**：因過失或意外致疫苗短少或毀損；非合約院所執行醫護等人員接種，其毀損比照合約院所相關罰則及規定辦理
- **處置流程**：
 - **不涉及接種異常事件**：如疫苗掉落毀損、疫苗遺失等情形，合約院所應填寫「**衛生局毀損流感疫苗（無需）賠償案件報告表**」通知轄區衛生局(所)
 - **涉及接種異常事件**：如疫苗種類/劑量錯誤、重複接種、接種間隔不足、打錯人、接種屆期疫苗等情形，因涉接種個案後續健康情形之追蹤，合約院所應儘速填寫「**流感疫苗接種異常事件暨毀損賠償報告表**」，通知轄區衛生局(所)。衛生局(所)應依實際發生情形，參考公費疫苗毀損賠償等級並依「115年疫苗賠償縣市等級計算表」（另以電郵寄送）進行賠償計價審核後，於「全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)」之「毀損登錄」中進行通報，並將「衛生局毀損疫苗(無需)賠償案件報告表」或「流感疫苗接種異常事件暨毀損賠償報告表」經機關首長核章後按月函送疾病管制署各區管制中心

※倘為初犯或發現錯誤主動通報並積極處理，可先請院所提出檢討改善措施或由衛生局提供再次教育訓練，由衛生局確認造成異常情形已排除，或易造成錯誤之接種流程已改善後，可酌情無需賠償

不須把毀損處理與賠償等級做連結

接種作業注意事項及重點對象接種情形

接種對象事前造冊

- 各類流感疫苗公費接種對象，原則上因目前接種資料已上傳NIIS，故事前造冊對象僅包括安養、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員、防疫人員、禽畜養殖業等及動物防疫人員，因為統計接種率需有母數資料，或沒有可供辨識的職業別證照，故仍維持造冊

流感疫苗接種地點

- 合約院所：

- 地區級以上醫院
- 診所
- 衛生所

- 
- 提供假日、夜間接種服務
 - 引導民眾優先至合約院所接種
 - 推廣民眾進入合約院所後併同接種

- 社區、企業接種站：

- 民眾在自己的社區與工作場所接種，更省時便利

- 到宅接種：

- 提供行動不便民眾接種服務

- 安養、長期照顧(服務)等機構：

- 由專業醫護人員進駐提供接種服務

- 校園集中接種：

- 國小到高中/職及五專學生於校園接種

合約院所資料維護及管理

● 請各縣市衛生局務必於**9/24前**：

1. 將合約院所名單公布於衛生局網站，如有異動應即時更新，並將網址連結及名冊電子檔電郵本署
2. 至全國性預防接種資訊管理系統(NIIS) [3.3.1維護合約狀態](#)，以利據以更新**流感新冠肺鏈疫苗及流感藥劑地圖**資訊，並避免影響接種處置費核算

序號	接種類別	狀態	合約起日
1	流感	待選約	---
2	COVID-19	合約中	1140401



接種異常事件通報及處理

① 發生接種異常事件



疫苗種類/劑量錯誤、重複接種、
提前接種、接種屆期疫苗等

② 合約院所



1. **應立即**通報衛生局(所)
2. 通知個案或家長
3. 追蹤並協助就醫



④ 疾管署各區管中心

1. 協助處理個案狀況及安撫情緒
2. 彙整相關資料及**按週回報**整備組



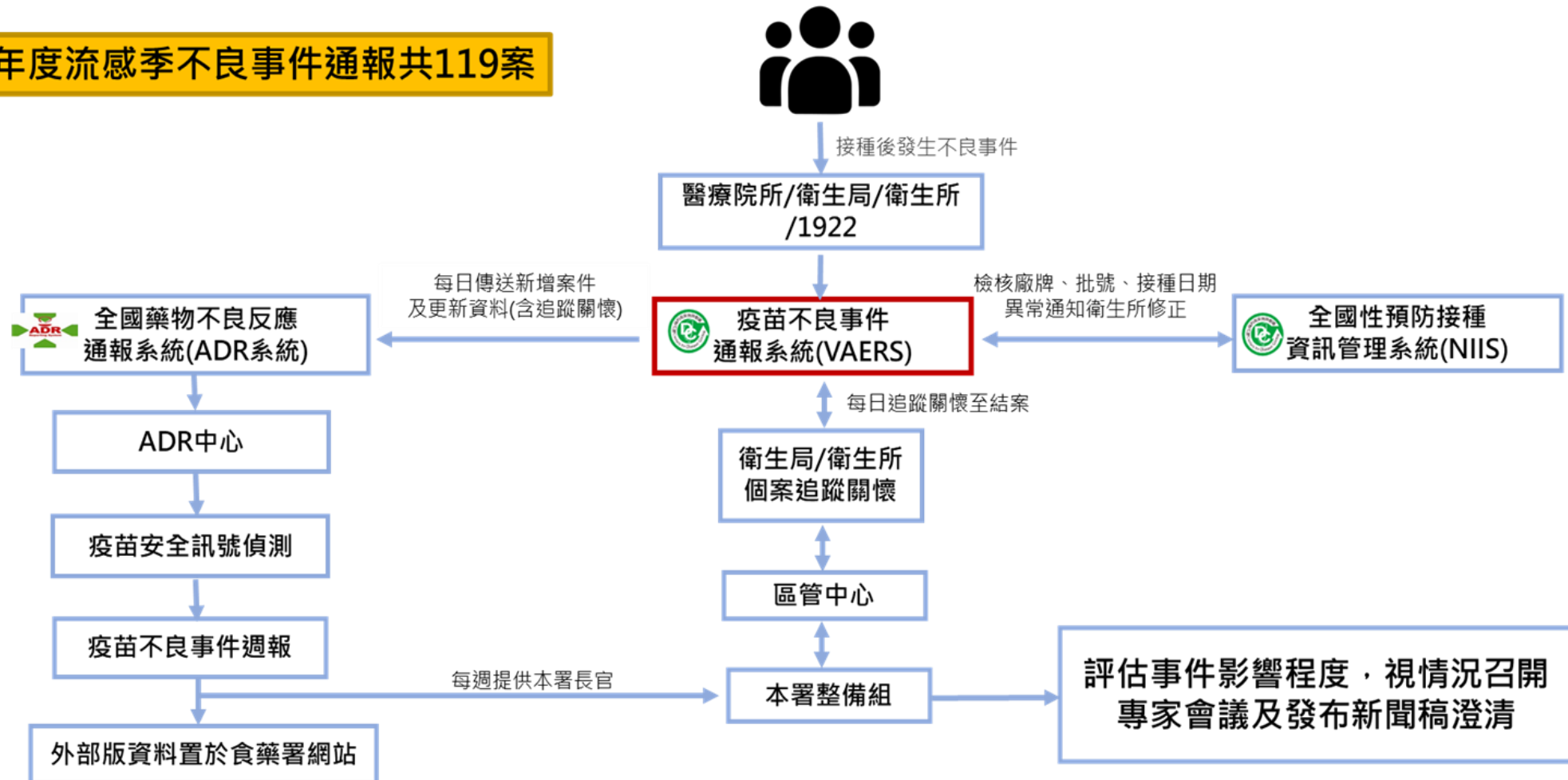
③ 衛生局(所)

1. 填寫「流感疫苗異常事件暨毀損賠償報告表」並通報疾管署各區管中心
2. 追蹤至痊癒或至少2週，主動關懷與應對需求
3. 督導醫療院所提供必要協助

公費疫苗毀損賠償請依「115年度賠償縣市等級計算表」進行賠償計價，並於「全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)」之「毀損登錄」進行通報。

流感疫苗嚴重不良事件及接種異常事件之因應

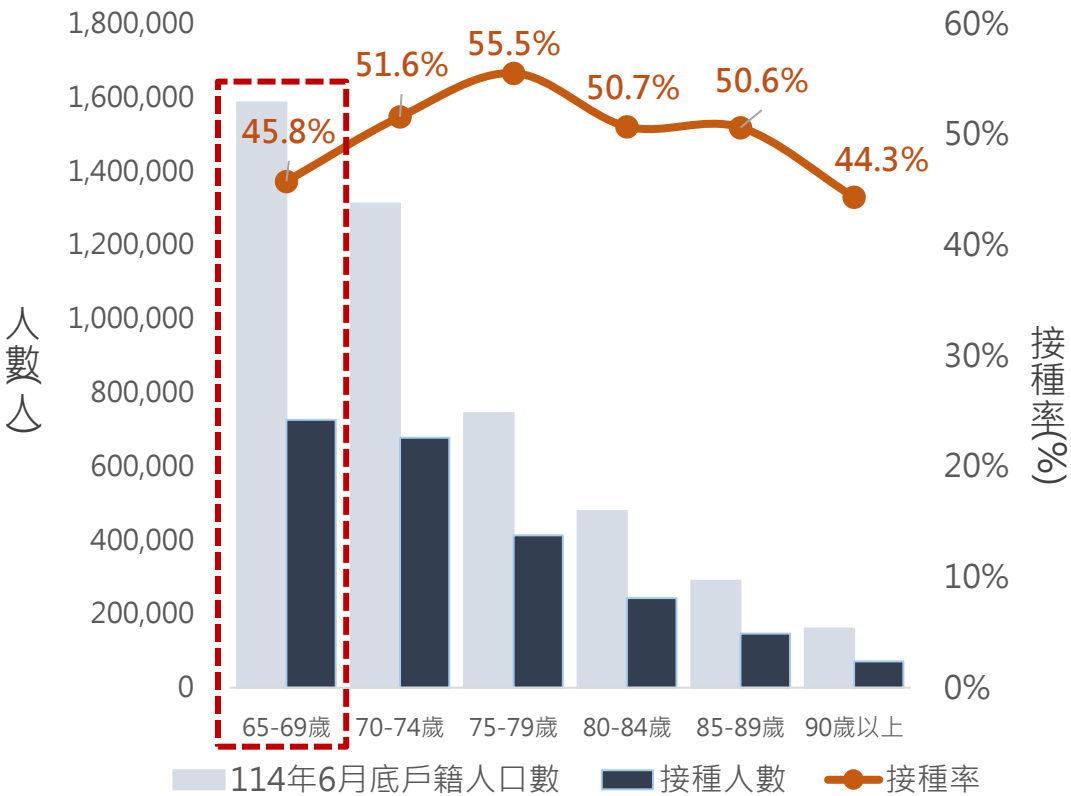
114年度流感季不良事件通報共119案



114年重點族群接種情形分析-65歲以上長者(1)

- ◆ 按長者就醫科別就醫人次統計，各層級醫院均以**內科**(含其次專科，如：心臟血管內科、內分泌科、消化內科、腎臟內科等)**就醫人次所占百分比最高**，約四至五成，其餘科別就醫人次百分比請參見下表
- ◆ 按長者接種年齡進一步細分，接種率最低為**90歲以上(44.3%)**，其次為**65-69歲(45.8%)**

醫學中心		區域醫院		地區醫院	
就醫科別	就醫人次百分比	就醫科別	就醫人次百分比	就醫科別	就醫人次百分比
內科	48.3%	內科	46.3%	內科	42.2%
外科	9.7%	神經科	9.0%	骨科	9.7%
神經科	8.3%	外科	7.8%	家醫科	8.8%
泌尿科	6.4%	泌尿科	6.7%	復健科	8.2%
眼科	5.9%	骨科	6.2%	神經科	7.9%
骨科	4.3%	家醫科	6.1%	外科	6.2%
家醫科	4.0%	眼科	4.7%	泌尿科	5.3%
耳鼻喉科	2.1%	復健科	3.5%	眼科	4.1%
復健科	2.1%	精神科	3.0%	精神科	2.7%
精神科	2.1%	耳鼻喉科	1.9%	耳鼻喉科	1.4%



就醫人次百分比：該層級醫院就醫科別就醫人次/該層級醫院所有就醫科別總就醫人數*100%

114年重點族群接種情形分析-65歲以上長者(2)

- ✓ 114年10月1日至12月31日NIIS接種量與健保就醫人數資料：
- 65歲以上接種院所層級占比：診所(51.7%)>衛生所(32.3%)>地區醫院(7.3%)>區域醫院(4.4%)>醫學中心(4.3%)
 - 醫院之65歲以上就醫接種比例低於診所、衛生所

全國資料		健保就醫資料(歸人)及流感疫苗接種資料					
		65歲以上			不分年齡		
合約院所層級	各層級家數占比	就醫人數(占比)	接種數 (占比)	就醫接種比例	就醫人數(占比)	接種數 (占比)	就醫接種比例
		426.9萬	154.8萬	36.3%	1,780.8萬	384.5萬	21.6%
醫學中心	0.3%	55.9萬(13.1%)	6.6萬 (4.3%)	11.8%	178.2萬 (10.0%)	28.9萬 (7.5%)	16.2%
區域醫院 ^{註1}	1.0%	72.0萬(16.9%)	6.7萬 (4.4%)	9.3%	222.3萬 (12.5%)	28.2萬 (7.3%)	12.7%
地區醫院	3.3%	50.3萬(11.8%)	11.3萬 (7.3%)	22.5%	152.2萬 (8.5%)	34.9萬 (9.1%)	22.9%
診所	92.1%	204.4萬(47.9%)	80.1萬 (51.7%)	39.2%	1,151.6萬 (64.7%)	193.6萬 (50.3%)	16.8%
衛生所 ^{註2}	3.4%	44.3萬(10.4%)	50.1萬 (32.3%)	113.1%	76.3萬 (4.3%)	98.8萬 (25.7%)	129.5%

註1：含臺北市立聯合醫院9個院區(陽明、中興、仁愛、林森、婦幼、和平、松德、忠孝、昆明)；註2：含臺北市立聯合醫院12個門診部，不含12個健康服務中心

資料來源：健保署門診就醫申報資料(不含中醫及牙醫)；費用年月11410-11412)；BO流感疫苗接種紀錄(按身分別統計)；資料時間114/10/01-12/31

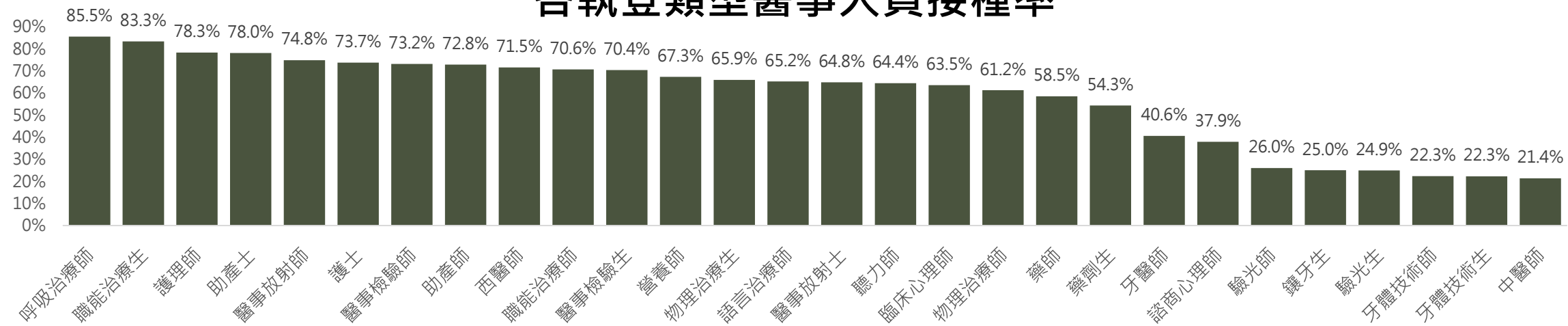
114年重點族群接種情形分析-醫事執登人員(1)

資料自114/10/1截至115/2/17

催注醫事
機構目標

特約醫事機構類別	醫事人員執登數	醫事人員接種數	醫事人員接種率
醫學中心	78,095	62,060	79.5%
區域醫院	77,352	62,272	80.5%
地區醫院	41,752	34,334	82.2%
診所	87,310	51,496	59.0%
藥局	13,194	5,785	43.8%
其他	67,886	34,581	50.9%

各執登類型醫事人員接種率



醫事人員類別	呼吸治療師	職能治療生	護理師	助產士	醫事放射師	護士	醫事檢驗師	助產師	西醫師	職能治療師	醫事檢驗生	營養師	物理治療生	語言治療師	醫事放射士	聽力師	臨床心理師	物理治療師	藥師	藥劑生	牙醫師	諮商心理師	驗光師	鑲牙生	驗光生	牙體技術師	牙體技術生	中醫師
應接種數	2,405	162	177,924	82	7,769	15,927	10,679	125	56,113	4,848	125	4,360	1,585	1,927	54	520	2,307	8,900	32,264	5,124	16,704	4,477	4,217	8	4,247	1,948	813	8,210
接種數	2,057	135	139,324	64	5,814	11,741	7,813	91	40,143	3,425	88	2,935	1,045	1,256	35	335	1,466	5,448	18,867	2,784	6,784	1,698	1,096	2	1,057	435	181	1,755

114年重點族群接種情形分析-醫事執登人員(2)

資料自114/10/1截至115/2/17

6都藥事人員較多，接種率普遍較低，可結合地方公會進行催注

縣市	藥劑生			藥師		
	應接種數	接種數	接種率	應接種數	接種數	接種率
臺北市	478	258	54.0%	5,323	2,963	55.7%
新北市	872	440	50.5%	4,652	2,488	53.5%
基隆市	99	65	65.7%	351	214	61.0%
宜蘭縣	55	25	45.5%	506	314	62.1%
金門縣	4	3	75.0%	42	23	54.8%
連江縣	0	0	0.0%	10	7	70.0%
桃園市	460	251	54.6%	2,627	1,475	56.1%
新竹縣	139	78	56.1%	620	334	53.9%
新竹市	150	81	54.0%	564	337	59.8%
苗栗縣	206	110	53.4%	412	250	60.7%
臺中市	668	367	54.9%	4,461	2,741	61.4%
彰化縣	322	196	60.9%	1,414	913	64.6%
南投縣	162	89	54.9%	503	313	62.2%
雲林縣	161	83	51.6%	749	448	59.8%
嘉義縣	84	45	53.6%	512	318	62.1%
嘉義市	61	33	54.1%	607	406	66.9%
臺南市	268	150	56.0%	2,963	1,742	58.8%
高雄市	662	364	55.0%	4,263	2,609	61.2%
屏東縣	163	95	58.3%	1,003	594	59.2%
澎湖縣	16	9	56.3%	58	34	58.6%
花蓮縣	60	25	41.7%	412	220	53.4%
臺東縣	34	17	50.0%	212	124	58.5%
總計	5,124	2,784	54.3%	32,264	18,867	58.5%

提升醫院醫事執登人員接種率

1

提供地區層級(含)以上醫院 執登醫事人員接種率報表



目的

協助衛生局掌握轄區醫院醫事人員流感疫苗接種狀況



執行方式

- 時間：115年10月至12月
- 頻率：每月第2、4週的週五(遇假日順延)
- 由CDC彙整資料並提供各縣市衛生局



注意：與NIIS 14.12身分別報表計算方式不同

2

跨部會合作



目的

提升所屬醫院醫事人員接種率



執行方式

- 主管機關：**教育部、退輔會及軍醫局**
- 協助鼓勵所屬醫院醫事人員及早接種流感疫苗

3

公私協力



目的

透過動員相關醫事團體參與，提升醫事人員接種率



執行方式

- 衛生局、CDC
- 針對**藥師、醫檢師、驗光師**等醫事團體
- 鼓勵會員接種(提供素材/列入會訊/辦理活動/發函等)

提升機構及居家照護對象接種率(1/2)

長期照顧服務申請及給付辦法

- 長照服務員陪同欲接種之65歲以上長者至院所接種流感疫苗
- 申請「陪同外出」(BA13)或「陪同就醫」(BA14)之服務費用(依實務認定)

全民健康保險家庭醫學醫師整合性照護計畫

- 評核指標「65歲以上老人流感注射率(4分)」
 1. 會員接受流感注射服務 $\geq$ 較需照護族群 65 百分位數，得 4 分
 2. $<$ 較需照護族群 65 百分位數，但 $\geq$ 較需照護族群 55 百分位數，得 2 分
 3. 計算公式說明：分子=65 歲以上會員於院所接種流感疫苗人數。分母=65 歲以上總會員人數
- 資料來源：處置費申報資料^{註1}

全民健康保險偏鄉地區全人整合照護執行方案

- 健康管理指標之必選指標列入「65 歲以上民眾流感疫苗接種率^{註2}」，可獲醫療品質回饋點數
- 執行地區：全民健康保險山地離島地區及嘉義縣大埔鄉、花蓮縣豐濱鄉

全民健康保險居家醫療照護整合計畫

- 特約醫事服務機構至病人家執行居家醫療服務，得併行健保代辦之醫療服務（流感疫苗接種）
- 除原有訪視費外，另可申請疫苗接種處置費

註1：本指標係由健保署撈取合約院所接種處置費之申報資料計算，非NIIS產製

註2：本指標係以 NIIS 14.12 資料計算（身分別：F03A、F03B、F04A 及 F04B）

提升機構及居家照護對象接種率(2/2)

長照司

- 年底秋冬(流感、新冠疫苗接種期間)
- 鼓勵居家照顧服務員，提醒被照顧者接種疫苗
- 居家照顧服務員可申請陪同外出或陪同就醫費用

衛生局

- 流感、新冠疫苗開打前、接種期間
- 提醒合約院所，積極參與全民健康保險相關計畫與方案
- 合約院所可併行申請接種處置費，或獲得品質提升費用

● 長期照顧服務申請及給付辦法附表四「照顧組合表」

碼別	照顧組合名稱	組合內容及說明	給(支)付價格(新臺幣/元)	原民區或離島支付價格(新臺幣/元)
BA13	陪同外出	一、內容：外出工具之安排、陪同外出，及注意安全，以每三十分鐘為一給(支)付單位。 二、外出目的包括：購物、社交活動、辦理事務、參與宗教活動、用餐、散步、上下學、定期式復健或透析治療、運動或其他情形。 三、本組合金額不包括外出之交通工具；如符合 BA12 之給付條件，則本組合與 BA12 併同使用。	195	235

碼別	照顧組合名稱	組合內容及說明	給(支)付價格(新臺幣/元)	原民區或離島支付價格(新臺幣/元)
BA14	陪同就醫	一、內容：協助掛號(含預約)、長照給付對象準備、陪同就診、聽取及轉知醫囑與注意事項。 二、本組合價格不包括長照給付對象及陪同之照顧服務員之就醫交通工具費用。 三、本組合不適用定期式復健或透析治療。 四、本組合以陪同長照給付對象就醫為主，陪同時間自案家出門起算一點五小時內，適用本組合。超過一點五小時，得依實際陪同就醫時數使用 BA13。	685	825

115年度重點對象接種目標

對象	目標接種率	114年度接種率 (截至115/6/30)
65歲以上長者	55%	51.5%
學齡前幼兒	65%	69.7%
醫事執登人員	75%	73.1%
學生	75%	72.4%

※各縣市重點對象接種率，將列為**116年度**本署補助衛生局辦理流感疫苗接種工作計畫**經費核定**之參考！

結語

- **115年接種政策更新**：115年採購加強型流感疫苗，優先提供安養及長期照顧(服務)等機構65歲以上長者公費接種；依ACIP會議決議，更新我國幼兒流感疫苗接種建議
- **處置費核付變革**：自115年3月1日起，流感疫苗接種處置費取消原有健保申報作業，改由疾管署依NIIS接種資料及「兒童常規疫苗、成人肺炎鏈球菌疫苗、新冠疫苗及流感疫苗接種處置費補助作業計畫」規定核付；請合約院所於開打前，務必向HIS廠商確認已關閉健保處置費申報路徑
- **疫苗冷儲管理與不良品通報**：流感疫苗存放於2~8°C、冷藏櫃次低溫層，明顯標示且公自費分開存放；若發現疫苗不良品，應通知衛生局並填報通報表
- **重點對象接種率提升**：
 1. 長者：除持續透過4千家合約院所、入機構、到宅及社區設站等多元服務管道，增進接種便利性與可近性外，並結合長照居服員陪同就醫協助長者接種，以及搭配健保居家醫療與家醫計畫提供到宅接種方案，透過跨域資源整合，共同提升長者接種率
 2. 醫事人員：針對基層或特定職業別醫事人員(如：牙醫師、藥師、藥劑生、驗光師/生等)，結合地方公協會力量加強宣導催注，共同提升醫事人員接種率

感謝 聆聽

疾管署全球資訊網
www.cdc.gov.tw

免付費疫情通報與諮詢專線 1922

更多資訊：

- 疾管署流感併發重症專區
https://www.cdc.gov.tw/Disease/SubIndex/x7jzGIMMuIeuLM5izvwg_q
- 流感疫苗接種計畫
https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/JNTC9qza3F_rgt9sRHqV2Q
- 醫事人員學會/公會課程教材
https://www.cdc.gov.tw/File/Get/_BOVPe7DcKZpsvEcyoYktA